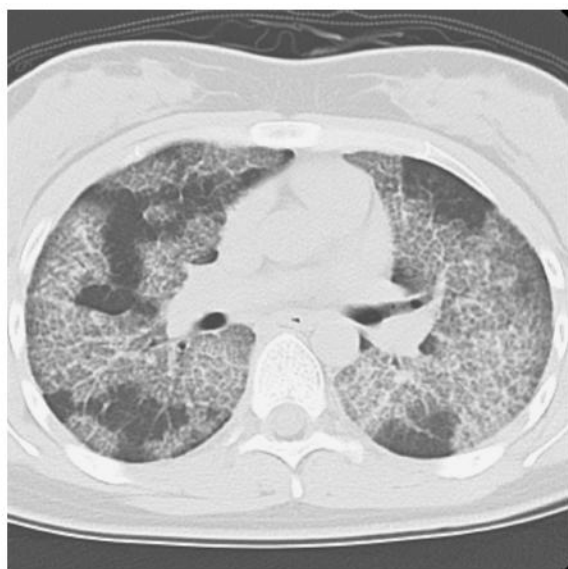




a.



b.

図1 PAPの胸部X線像(a)と胸部HRCT(b)

16%のみであり、有症状として、発熱が45%、労作時呼吸困難が42%、咳嗽が42%であったと報告されている。CPAP/HPAPでは重篤な症例が多い。

身体所見は基本的には乏しいが、捻髪音、ばち指、チアノーゼなどを認めることがある。

診断・検査

a 検査

i) 胸部X線

APAPでは、両側中下肺野を中心にびまん性にすりガラス影・浸潤影を認め、肺尖部や肋骨横隔膜角には陰影は認めないことが多い（図1a）。しかし、陰影が自然寛解したり、移動する場合もあり、長期の罹患例では線維化を伴うことが散見される。

SPAPでは、中下肺野の優位性も乏しく、陰影は多彩である。

ii) 胸部HRCT

APAPでは、すりガラス影および小葉間隔壁の肥厚が重なり合った、いわゆる crazy-paving appearance を認める。典型的には、陰影は両側性で、正常部と病変部が明瞭に境される地図状分布（geographic distribution）を呈し、胸膜直下の肺野領域は正常に保たれ、陰影は回避される（subpleural sparing）（図1b）。長期の罹患例では、嚢胞、牽引性の気管支拡張像、蜂巣肺などを認めることがある。

SPAPでは、すりガラス影が主体であるものの、辺縁が不鮮明であることが多く、APAPの典型的所見である crazy-paving appearance、地図状分布、胸膜直下の陰影回避がみられる頻度が低い¹⁾。

CPAP/HPAPでは、初期には両側肺底部に浸潤影

を伴うびまん性の微細網状粒状影がみられ、広範な浸潤影を伴う症例は予後不良であることが報告されている¹⁾。

iii) 血液

PAPの血清中では、間質性肺炎マーカーであるLDH、KL-6、SP-D、SP-Aおよび腫瘍マーカーであるCEA、CYFRAが上昇し、病勢評価に有用である。

また、APAPの血清中では、抗GM-CSF抗体が疾患特異的に認められ、先に述べた通り、これがAPAPの病因として同定されている。これまでの報告では、抗GM-CSF抗体価とAPAPの病勢が相関するエビデンスは示されていない。なお、抗GM-CSF抗体価は現状、定量評価ではなく定性評価で測定されている。

iv) 呼吸機能

APAPでは、基本的には%VC、%FVC、FEV₁%の低下は認めないが、%DLCOの低下を認める報告が複数存在している³⁾。また、重症度が上がるにつれ、拘束性障害を呈する可能性が高まる。

SPAPおよびCPAP/HPAPにおいても、%DLCOの低下を認める報告が存在しているが、報告数が極めて少ない。

v) 気管支肺胞洗浄

気管支肺胞洗浄液（bronchoalveolar lavage fluid：BALF）の外観は、“米のとぎ汁様”と表現されるように白濁～黄白色を呈し、時間の経過とともに沈殿する。

BALFの細胞分画では、リンパ球が増多する報告が多く、泡沫状マクロファージ（foamy macrophage）の増多も認められる。BALFをPAS染色すると、PAS陽性の顆粒状の無構造物質の沈着が散見され、Papa-